

ESCALA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

SRS-2

Relatório Técnico Completo

Dados do avaliado

NOME

Luciana Aparecida de Oliveira

IDADE

42 anos

PROFISSIONAL

Dra. Jacqueline O. Caires - CRP09/6017

SEXO

Feminino

ESCOLARIDADE

Ensino superior

TABELA NORMATIVA

Adulto Autorrelato

Finalidade do relatório técnico

Este documento apresenta os resultados psicométricos do SRS-2 com rastreabilidade ampliada: critérios interpretativos, perfil normativo, tabela de escores, detalhes por escala, estatísticas de respostas, leitura clínica e recomendações técnicas. Os achados devem ser interpretados por profissional habilitado e integrados aos demais dados da avaliação.

Visão geral

Descrição do instrumento

A Escala de Responsividade Social – Segunda Edição (SRS-2) mensura, em formato dimensional, indicadores associados à responsividade social, comunicação social recíproca e padrões restritos e repetitivos. Seus resultados contribuem para rastreio, planejamento de intervenção e análise clínica, mas não devem ser utilizados isoladamente para estabelecer diagnóstico.

ESCORE TOTAL

**Nível
moderado**

T 70

MAIOR ESCORE

**Motivação
Social**

T 74

RESPONDENTE

Responsável

0 miss.

STATUS

**Aplicação
válida**

SRS-2

Critérios interpretativos

● **T ≤ 59** Dentro dos limites normais

● **60-65** Nível leve

● **66-75** Nível moderado

● **≥ 76** Nível severo

Estrutura do relatório

1. Visão geral e critérios

2. Perfil dos Escores T

3. Tabela e mapa dos domínios

4. Radar clínico

5. Detalhes por escala

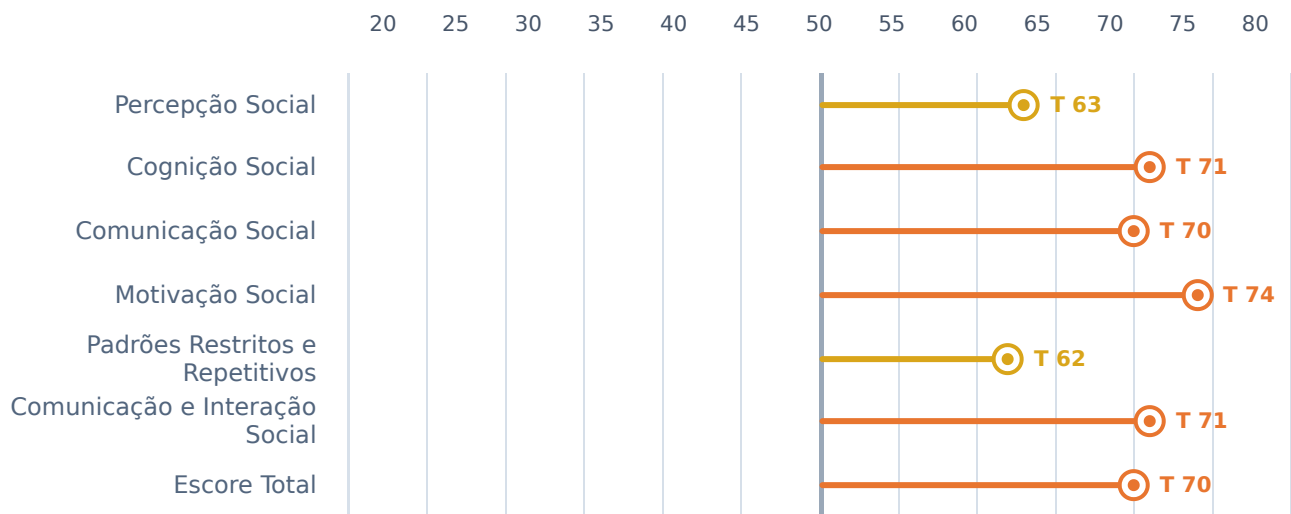
6. Estatísticas das respostas

7. Síntese técnica e recomendações

Perfil

Perfil dos Escores T

Distribuição dos escores T por dimensão, com média normativa em T=50.



LEITURA

Perfil global em nível moderado

O Escore Total está em nível moderado, com T=70.

MAIOR DOMÍNIO

Motivação Social

Maior escore do protocolo, com T=74.

NORMALIDADE

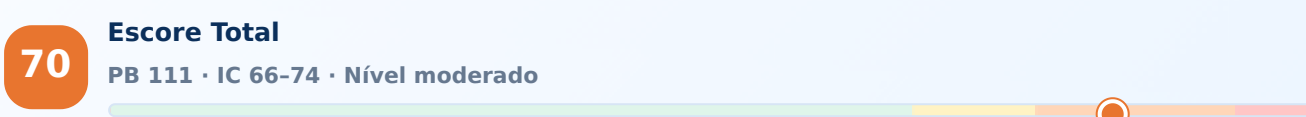
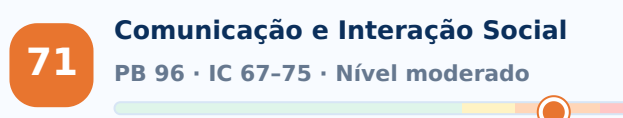
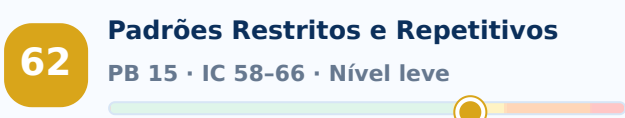
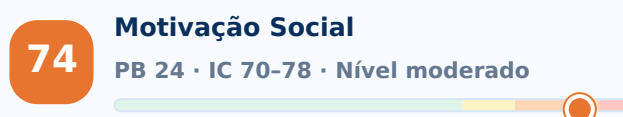
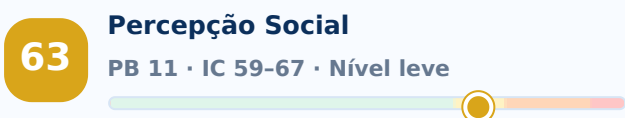
Domínios preservados

não informado permanecem dentro dos limites normativos.

Tabela de escores

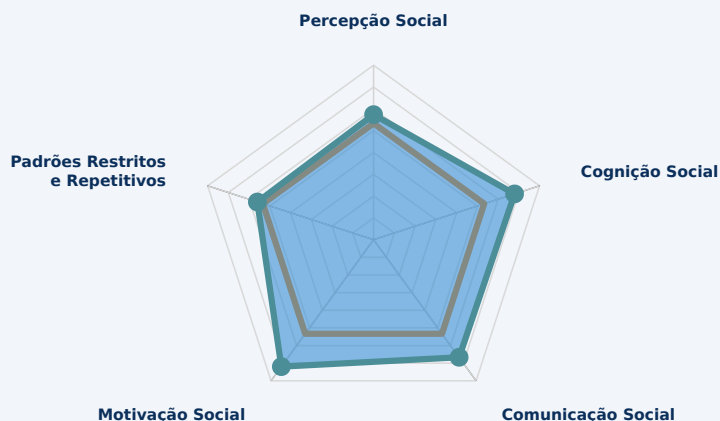
Escala	Pontuação bruta	Escore T	IC	Classificação
Percepção Social	11	63	59-67	Nível leve
Cognição Social	22	71	67-75	Nível moderado
Comunicação Social	39	70	66-74	Nível moderado
Motivação Social	24	74	70-78	Nível moderado
Padrões Restritos e Repetitivos	15	62	58-66	Nível leve
Comunicação e Interação Social	96	71	67-75	Nível moderado
Escore Total	111	70	66-74	Nível moderado

Mapa dos domínios



Radar clínico

Radar clínico dos domínios



Percepção Social	T 63
Cognição Social	T 71
Comunicação Social	T 70
Motivação Social	T 74
Padrões Restritos e Repetitivos	T 62

Leitura do radar

O radar apresenta a distribuição dos escores T entre os principais domínios do SRS-2. No protocolo de Luciana Aparecida de Oliveira, o Escore Total foi T=70 e o domínio mais elevado foi Motivação Social, com T=74.

O polígono sugere perfil global elevado em nível moderado, com maior expansão relativa no domínio Motivação Social. Esse gráfico deve ser usado para verificar se o perfil é homogêneo ou se existem picos específicos entre comunicação/interação social e padrões restritos ou repetitivos.

Detalhes da escala

Motivação Social

Pontuação bruta	24
Valor da norma	74
Respostas faltantes	0
Intervalo de confiança	70-78

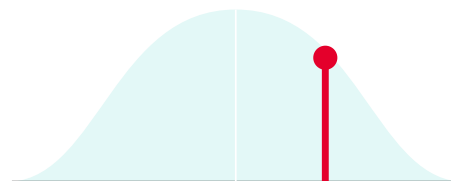
Refere-se ao grau de motivação para engajamento social e comportamento interpessoal.



Padrões Restritos e Repetitivos

Pontuação bruta	15
Valor da norma	62
Respostas faltantes	0
Intervalo de confiança	58-66

Mede rigidez, repetitividade, interesses restritos e dificuldades de flexibilidade comportamental.



Escore Total

Pontuação bruta	111
Valor da norma	70
Respostas faltantes	0
Intervalo de confiança	66-74

Representa a medida global de responsividade social do protocolo.



Estatísticas das respostas

Distribuição das respostas

Resposta	Percentu	
1	18%	
2	35%	
3	20%	
4	26%	

Informações extras

Não estão disponíveis informações extras para esta administração.

As informações extras são geradas quando um examinando troca a janela do teste por outra janela do computador.

Síntese técnica

Interpretação integrada

A Escala de Responsividade Social - Segunda Edição (SRS-2) foi aplicada com o objetivo de investigar possíveis dificuldades na comunicação social, cognição social, motivação social, percepção social e presença de padrões restritos e repetitivos, auxiliando no rastreio de indicadores associados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em análise clínica, o perfil obtido no SRS-2 evidenciou elevação global em nível moderado da responsividade social. Esse resultado indica comprometimento clinicamente relevante no funcionamento sociointeracional, podendo envolver prejuízos na comunicação social recíproca, na interpretação de situações interpessoais, no engajamento social e/ou na flexibilidade comportamental. A maior elevação ocorreu em Motivação Social, com Escore T=74.0, classificada como nível moderado.

O domínio de Percepção Social apresentou elevação em nível leve, sugerindo dificuldades discretas na identificação de pistas sociais básicas, como expressões faciais, gestos, tom de voz e sinais contextuais relevantes para a interação interpessoal. O domínio de Cognição Social apresentou elevação em nível moderado, indicando dificuldade clinicamente relevante para interpretar situações sociais, compreender intenções, reconhecer perspectivas e manejar regras sociais implícitas. O domínio de Comunicação Social apresentou elevação em nível moderado, indicando dificuldades clinicamente relevantes na comunicação social recíproca, incluindo sustentação de trocas comunicativas, adequação da linguagem ao contexto e uso integrado de recursos expressivos verbais e não verbais. Domínios elevados: Percepção Social, Cognição Social, Comunicação Social, Motivação Social e Padrões Restritos e Repetitivos.

O domínio de Motivação Social apresentou elevação em nível moderado, indicando dificuldades clinicamente relevantes no interesse espontâneo, na iniciativa social e no engajamento interpessoal, podendo refletir menor busca ativa por interação social. O domínio de Padrões Restritos e Repetitivos apresentou elevação em nível leve, sugerindo sinais discretos de rigidez comportamental, repetitividade, interesses restritos ou menor flexibilidade diante de mudanças. A escala de Comunicação e Interação Social apresentou elevação em nível moderado, indicando dificuldades clinicamente relevantes nos componentes centrais de reciprocidade social, comunicação interpessoal e manutenção de relações sociais. A Pontuação Total do SRS-2 situou-se em nível moderado, indicando comprometimento global clinicamente relevante da responsividade social, com impacto potencial na comunicação social recíproca, na interação interpessoal e/ou na flexibilidade comportamental. A elevação conjunta em Comunicação e Interação Social e Padrões Restritos e Repetitivos indica comprometimento nos dois grandes eixos sintomatológicos relacionados ao Transtorno do Espectro Autista, conforme descritos no DSM-5-TR. Esse achado não estabelece diagnóstico isoladamente, mas fortalece a necessidade de investigação clínica de características associadas ao TEA, especialmente quando houver convergência com anamnese, observação clínica, histórico do desenvolvimento e prejuízos funcionais.

Considerando exclusivamente os resultados do SRS-2, observa-se elevação clinicamente relevante na responsividade social. Esse achado não confirma diagnóstico isoladamente, mas sustenta a necessidade de investigar hipótese diagnóstica de Transtorno do Espectro Autista quando houver convergência com anamnese, observação clínica, histórico do desenvolvimento, funcionamento adaptativo e prejuízos funcionais.